



TEST

J2 Examen blanc 2023**Navigation du test**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130														

[Terminer le test...](#)TEMPS RESTANT **2:29:29**

QUESTION 1

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

L'hypercholestérolémie de type IIa est due à un ou plusieurs facteurs parmi les suivants :

- ☐ a. Un déficit en apoB100
- ☐ b. Un excès d'apports alimentaires en saccharose
- ☐ c. Une mutation gain de fonction de la PCSK9
- ☐ d. Un syndrome néphrotique
- ☐ e. Un myélome

QUESTION 2

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une hypertriglycéridémie à 5.6 mmol/l chez un adulte :

- ☐ a. Entraîne une pancréatite aigue
- ☐ b. Peut se normaliser avec l'équilibration d'un diabète
- ☐ c. Est traitée en première intention par les capsules à oméga 3
- ☐ d. Est fréquemment de type IV
- ☐ e. Peut être liée à l'excès de poids

QUESTION 3

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Concernant la douleur aiguë :

- ☐ a. Il s'agit d'une douleur qui s'est installée depuis moins d'un mois
- ☐ b. Ne doit pas être traitée par des antalgiques pour ne pas cacher son étiologie
- ☐ c. Est une douleur symptôme
- ☐ d. Peut-être plurifactorielle
- ☐ e. Est le plus souvent de nature neuropathique



QUESTION 4

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

La prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens :

- ☐ a. Doit être prudente en cas d'ulcère évolutif
- ☐ b. Est à éviter en cas de chiffres tensionnels élevés
- ☐ c. Est contre indiquée chez la personne âgée
- ☐ d. Est contraindiquée en association avec les antalgiques de pallier 2 à cause d'un phénomène de compétitivité
- ☐ e. Doit être couplée aux inhibiteurs de la pompe aux protons

QUESTION 5

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, précisez celle qui est juste
La vaccination d'un enfant de 6 ans selon le PNV comprend :

- ☐ a. dT-VPI-VHA
- ☐ b. dT
- ☐ c. VPO-VHA
- ☐ d. dT-VHA
- ☐ e. dT-VPO

QUESTION 6

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, précisez celles qui sont juste

La conduite à tenir devant un cas suspect de paralysie flasque aigue (PFA) comprend :

- ☐ a. Un isolement du patient pendant 60 jours
- ☐ b. Un examen à J60 du patient
- ☐ c. Une classification finale des cas de PFA par un comité national
- ☐ d. Une recherche du poliovirus par RT-PCR (réaction en chaine de la polymérase couplée à une transcription inverse) dans le sang du patient
- ☐ e. Une déclaration obligatoire au centre de pharmacovigilance

QUESTION 7

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, précisez celles qui sont justes.

L'immunogénécité d'un vaccin augmente avec :

- ☐ a. La présence d'un conservateur anti microbien
- ☐ b. La nature vivante de l'antigène vaccinal
- ☐ c. Le nombre des stéréotypes du germe correspondant contenus dans le vaccin
- ☐ d. La combinaison à un adjuvant
- ☐ e. La présence d'anticorps maternels chez l'enfant

QUESTION 8

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Chez un patient hypertendu avec une hypokaliémie, vous souhaitez exclure la prise de produits hypokaliémants. Parmi les produits suivants, lequel (lesquels) peu(ven)t induire une hypokaliémie :

- ☐ a. Amiloride
- ☐ b. Laxatif
- ☐ c. Hydrochlorothiazide
- ☐ d. Ramipril
- ☐ e. Indapamide

QUESTION 9

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Concernant les facteurs régulant l'excrétion urinaire de NH_4^+ , quelle(s) est (sont) les facteurs qui augmentent l'excrétion urinaire de NH_4^+ :

- ☐ a. L'hormone antidiurétique augmente l'excrétion urinaire de NH_4^+ dans le tube collecteur cortical
- ☐ b. L'aldostérone augmente l'excrétion urinaire de NH_4^+ dans le tube collecteur
- ☐ c. La baisse de la PaCO_2 provoque une alcalose métabolique ce qui entraîne une diminution de la sécrétion des ions H^+
- ☐ d. Le cortisol diminue la sécrétion de NH_4^+ et de H^+
- ☐ e. L'hyperkaliémie provoque une diminution de l'utilisation de la glutamine responsable d'une baisse de l'excrétion rénale de NH_4^+

QUESTION 10

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Concernant les systèmes tampon participant à l'équilibre acide base, quelle(s) est(sont) la (les) proposition(s) juste(s) :

- ☐ a. Le système tampon ne consomme pas d'énergie
- ☐ b. Le système tampon n'est pas disponible mais il peut être mis en jeu instantanément
- ☐ c. Le tampon phosphates inorganiques est un tampon extracellulaire dont le pK est proche du pH de l'organisme
- ☐ d. Le système tampon protéines est le système tampon le plus abondants
- ☐ e. Le système tampon assure une régulation fine

QUESTION 11

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les signes cliniques suivants, lequel (lesquels) peu(ven)t être en rapport avec une hyperhydratation intracellulaire :

- ☐ a. Nausées et vomissements
- ☐ b. Pli cutané
- ☐ c. Œdèmes des membres inférieurs
- ☐ d. Troubles de la conscience
- ☐ e. Une hypertension artérielle

QUESTION 12

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelle(s) est (sont) la (les) propositions exacte(s) concernant le contrôle du bilan hydrosodé :

- ☐ a. L'angiotensine II stimule le mécanisme de la soif
- ☐ b. La déplétion volémique inhibe le système rénine angiotensine aldostérone
- ☐ c. L'hormone antidiurétique inhibe le système rénine angiotensine aldostérone
- ☐ d. La déplétion volémique stimule la soif
- ☐ e. La déplétion volémique stimule l'hormone antidiurétique

QUESTION 13

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelle(s) est (sont) la (les) propositions(s) exacte(s) concernant le tube contourné proximal (TCP):

- ☐ a. Le TCP assure la réabsorption de plus 90 % du potassium filtré
- ☐ b. Au niveau du TCP, la réabsorption du sodium se fait grâce au co-transporteur Na/K/2Cl
- ☐ c. Le TCP assure 25% de la réabsorption totale
- ☐ d. La réabsorption de l'eau se fait principalement à travers des aquaporines de type 1 non contrôlée par l'hormone antidiurétique
- ☐ e. Le glucose est réabsorbé en totalité au niveau du TCP

QUESTION 14

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelle(s) est(sont) la (les) réponse(s) exacte(s) concernant le traitement médical d'une hyperkaliémie sévère à 7 mmol/l (en attendant la séance d'hémodialyse en urgence) avec acidose métabolique chez un patient présentant un œdème aigu pulmonaire et une échographie rénale normale :

- ☐ a. Administration d'insuline ordinaire avec du sérum glucosé
- ☐ b. Administration du calcium par voie intraveineuse
- ☐ c. Alcalinisation par bicarbonate de sodium isotonique
- ☐ d. Furosémide par voie intraveineuse
- ☐ e. Kayaxalate*

QUESTION 15

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une acidose métabolique avec une hyperkaliémie s'observe au cours de :

- ☐ a. Un traitement par diurétique de l'anse
- ☐ b. Diarrhée
- ☐ c. Une insuffisance surrénalienne
- ☐ d. Vomissements abondants
- ☐ e. Insuffisance rénale chronique avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/m

QUESTION 16

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les foramens au niveau de l'étage postérieur de la base du crane sont :

- ☐ a. Foramen Magnum
- ☐ b. Foramen Ovale
- ☐ c. Canal de l'hypoglosse
- ☐ d. Foramen Jugulaire
- ☐ e. Foramen épineux

QUESTION 17

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi ces différentes propositions, celles qui sont exactes :

- ☐ a. Le volume des secteurs artériels et parenchymateux reste toujours inchangé
- ☐ b. Les mécanismes de compensation face à un volume surajouté (masse) obéissent à la loi de Monroe-Kellie
- ☐ c. Si les mécanismes de compensation sont dépassés, la pression intra-cranienne augmente
- ☐ d. la boîte crânienne est inextensible
- ☐ e. Le volume des secteurs artériel et veineux reste toujours inchangé

QUESTION 18

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi ces différentes propositions, celles qui sont exactes :

- ☐ a. Les ACSOS sont la conséquence des troubles cardiorespiratoires et métaboliques
- ☐ b. L'hypertension intracrânienne fait partie des ACSOS
- ☐ c. Les conséquences de l'hypertension intra-cranienne sont les engagements
- ☐ d. L'œdème cytotoxique est une lésion secondaire d'origine systémique
- ☐ e. L'hydrocéphalie fait partie des ACSOC



QUESTION 19

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi ces différentes propositions, celles qui sont exactes :

- ☐ a. Les cascades de Rosner représentent la relation entre la pression artérielle moyenne, la pression de perfusion cérébrale et la pression intra-cranienne quand l'autorégulation est conservée
- ☐ b. L'hypocapnie vasoconstrictrice est un facteur d'ischémie cérébrale avec réduction du débit sanguin cérébral
- ☐ c. Dans la zone d'autorégulation cérébrale, l'augmentation de la pression de perfusion cérébrale entraîne une vasodilatation
- ☐ d. La pression artérielle moyenne supérieure à 150 mmHg entraîne une hyperhémie
- ☐ e. Dans la zone d'autorégulation cérébrale, le débit sanguin cérébral reste constant et ceci grâce à la vasomotricité des artérioles pie-mériennes

QUESTION 20

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les antigènes du système Rhésus sont :

- ☐ a. Immature à la naissance
- ☐ b. Des Groupes leucocytaires
- ☐ c. De nature Glucidiques
- ☐ d. Propres à l'Homme
- ☐ e. peu immunogène

QUESTION 21

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les indications du recours au PFC sont :

- ☐ a. Déficit en Facteur V
- ☐ b. Echange plasmatique pour un purpura thrombotique
- ☐ c. Surdosage en AVK
- ☐ d. Solution de remplissage
- ☐ e. Déficit en facteur VIII

QUESTION 22

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

L'association d'une splénomégalie-adénopathies peut se voir au cours d'une ou plusieurs des Hémopathies suivantes:

- ☐ a. Un myélome multiple
- ☐ b. Un syndrome myélodysplasique
- ☐ c. Une leucémie aiguë
- ☐ d. Une thrombocythémie essentielle
- ☐ e. Un lymphome hodgkinien

QUESTION 23

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une splénomégalie est présente habituellement au cours de la ou les pathologies suivantes :

- ☐ a. La thrombocythémie essentielle
- ☐ b. La sphérocytose héréditaire
- ☐ c. La forme double hétérozygote drépano- thalassémie
- ☐ d. Aplasie médullaire
- ☐ e. Le déficit en G6PD



QUESTION 24

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les éléments en faveur du caractère vasculaire du purpura sont :

- ☐ a. Evolution par poussées
- ☐ b. Aspect nécrotique
- ☐ c. Association à des gingivorragies minimales
- ☐ d. Caractère prurigineux
- ☐ e. Disparition à la vitropression

QUESTION 25

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les pathologies pouvant se manifester par un purpura vasculaire sont :

- ☐ a. Cryoglobulinémie
- ☐ b. Anémie mégalo-blastique
- ☐ c. Insuffisance cardiaque
- ☐ d. Syndrome de Sjogren
- ☐ e. Myélodysplasie

QUESTION 26

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Au cours du Purpura thrombopénique auto-immun (PTAI):

- ☐ a. L'administration d'immunoglobulines polyvalentes est proposée en cas de syndrome hémorragique sévère
- ☐ b. La présence d'une anémie n'exclut pas le diagnostic
- ☐ c. Le myélogramme montre la présence de nombreux mégacaryocytes
- ☐ d. Le fibrinogène est abaissé
- ☐ e. Le frottis sanguin montre des microplaquettes



QUESTION 27

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Devant Un purpura fébrile on évoque :

- ☐ a. Syndromes myélodysplasiques
- ☐ b. Sepsis compliqué de CIVD
- ☐ c. Endocardites
- ☐ d. Purpuras Fulminans méningococciques
- ☐ e. Rickettsioses

QUESTION 28

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le diagnostic de purpura thrombotique thrombopénique est confirmé par:

- ☐ a. Une exploration de la protéine ADAMTS (activité et anticorps anti- ADAMTS13)
- ☐ b. Recherche d'anticorps anti-nucléaires
- ☐ c. Une sérologie VIH
- ☐ d. Un scanner cérébral
- ☐ e. Un dosage de β -HCG

QUESTION 29

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les signes de gravité du purpura sont:

- ☐ a. Le purpura fébrile
- ☐ b. Le caractère ecchymotique
- ☐ c. La localisation déclive
- ☐ d. Le caractère extensif
- ☐ e. Le caractère nécrotique



QUESTION 30

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les situations pouvant se manifester par un purpura thrombopathique sont :

- ☐ a. L'Insuffisance hépato-cellulaire
- ☐ b. La maladie de Bernard Soulier
- ☐ c. L'Insuffisance rénale chronique
- ☐ d. La prise d'AINS
- ☐ e. Purpura post transfusionnel

QUESTION 31

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelle exploration paraclinique demandez-vous de première intention chez un patient polytraumatisé avec un état de choc réfractaire ?

- ☐ a. Fast échographie
- ☐ b. Aucune exploration
- ☐ c. Radiographie du thorax au lit du patient
- ☐ d. Radiographie du bassin
- ☐ e. Un scanner corps entier

QUESTION 32

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Au cours de la leishmaniose viscérale, la splénomégalie est associée, sur le plan biologique, à :

- ☐ a. Une microcytose
- ☐ b. Une hyperlymphocytose
- ☐ c. Une hyperleucocytose
- ☐ d. Une anémie normochrome normocytaire arégénérative
- ☐ e. Une thrombopénie



QUESTION 33

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Devant une adénopathie cervicale associée à un syndrome mononucléosique, la parasitose à évoquer est :

- ☐ a. La toxoplasmose
- ☐ b. La leishmaniose cutanée
- ☐ c. L'hydatidose
- ☐ d. La leishmaniose viscérale
- ☐ e. Le paludisme

QUESTION 34

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Devant une splénomégalie fébrile chez un enfant, les éléments orientant vers une leishmaniose viscérale sont :

- ☐ a. La consommation de lait non pasteurisé
- ☐ b. La consanguinité parentale
- ☐ c. L'âge inférieur à 5 ans
- ☐ d. L'habitat à Kairouan
- ☐ e. Le contact avec des chats errants

QUESTION 35

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le(s) traitement(s) qui peut(vent) être administré(s) devant une trichomonose vulvo-vaginale est(sont) :

- ☐ a. Métronidazole en prise unique
- ☐ b. Tinidazole en prise unique
- ☐ c. Fluconazole en prise quotidienne pendant 7 jours
- ☐ d. Ciprofloxacine pendant 7 jours
- ☐ e. Fluconazole en prise hebdomadaire pendant un mois



QUESTION 36

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les signes cliniques en faveur d'une trichomonose vulvo-vaginale sont :

- ☐ a. La fièvre
- ☐ b. Le prurit vulvaire
- ☐ c. La présence de verrues vulvaires
- ☐ d. La dyspareunie
- ☐ e. Les pertes vaginales verdâtres nauséabondes

QUESTION 37

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Devant tout œdème localisé fébrile, selon la localisation, il faut éliminer en urgence :

- ☐ a. Ethmoïdite aiguë
- ☐ b. Lymphangite
- ☐ c. Staphylococcie maligne de la face
- ☐ d. Fasciite nécrosante streptococcique
- ☐ e. Endocardite infectieuse

QUESTION 38

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les mécanismes des œdèmes, la(les)quelle(s) de ces propositions est(sont) vraie(s) :

- ☐ a. Une réabsorption tubulaire rénale primitive du sodium
- ☐ b. Une augmentation de la perméabilité capillaire
- ☐ c. Une diminution de la pression oncotique capillaire
- ☐ d. Un blocage à l'évacuation par le réseau lymphatique
- ☐ e. Une diminution de la pression hydrostatique capillaire



QUESTION 39

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quel secteur du milieu intérieur est touché au cours des œdèmes ?

- ☐ a. Capillaire
- ☐ b. Plasmaticque
- ☐ c. Artériel
- ☐ d. Lymphatique
- ☐ e. Interstitiel

QUESTION 40

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Un œdème blanc, mou, prenant le godet chez un sujet âgé édenté et diabétique peut être expliqué par :

- ☐ a. Une diminution de la perméabilité capillaire
- ☐ b. Une déshydratation extra cellulaire
- ☐ c. Une diminution de la Pression oncotique
- ☐ d. Une dénutrition
- ☐ e. Une hypotension artérielle

QUESTION 41

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Au cours d'une colique néphrétique d'origine lithiasique (une ou plusieurs réponses)

- ☐ a. La douleur est due à l'augmentation brutale de la pression dans les cavités rénales en aval du calcul
- ☐ b. La douleur évolue par poussée
- ☐ c. La restriction hydrique permet de soulager la douleur
- ☐ d. Les AINS permettent de réduire les pressions dans les cavités rénales
- ☐ e. L'intensité de la douleur est corrélée à la taille du calcul



QUESTION 42

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Au cours d'une colique néphrétique d'origine lithiasique les AINS (une ou plusieurs réponses):

- ☐ a. Diminuent l'œdème et l'inflammation pariétal
- ☐ b. Favorisent la baisse de la pression intra cavitaier
- ☐ c. Favorisent l'élimination des calculs par stimulation du péristaltisme urétérale
- ☐ d. Stimulent la synthèse des prostaglandines
- ☐ e. Favorisent la baisse de la filtration glomérulaire

QUESTION 43

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le(s) caractéristique(s) des calculs cystiniques est(sont):

- ☐ a. Aspect macroscopique jaune clair
- ☐ b. Résistants à la LEC
- ☐ c. Liée à une anomalie héréditaire dominante
- ☐ d. Récidivantes
- ☐ e. Sont solubles dans les urines

QUESTION 44

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le(s) étape(s) de la formation de calcul urinaire est (sont):

- ☐ a. La sursaturation en inhibiteur de la lithogénèse
- ☐ b. La rétention des cristaux
- ☐ c. La formation du couple oxalate de calcium-citrate
- ☐ d. La nucléation
- ☐ e. La croissance cristalline

QUESTION 45

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le(s) principal(aux) inhibiteur(s) de la croissance Cristalline dans les urines au cours de la lithogénèse

- ☐ a. Protéine de Tamm-Horsfall
- ☐ b. Citrate
- ☐ c. Les AA d'ADN
- ☐ d. Les Pyrophosphates
- ☐ e. Glycosamino-glycane

QUESTION 46

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les calculs d'Acide Urique ont les caractéristiques (une ou plusieurs propositions) :

- ☐ a. Favorisés par la résection de l'intestin grêle
- ☐ b. Visible sur l'AUSP
- ☐ c. Fréquent chez le sujet jeune
- ☐ d. Soluble en milieu à $\text{pH} < 5$
- ☐ e. Résistants à la LEC

QUESTION 47

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les caractéristiques des calculs d'oxalate de calcium Monohydraté (Whewellite) est(sont):

- ☐ a. Les moins fréquents
- ☐ b. De petite taille
- ☐ c. De couleur brunâtre
- ☐ d. Calcium-dépendants
- ☐ e. D'aspect spiculé



QUESTION 48

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les deux principaux calculs réputés résistants à la Lithotripsie Extra Corporelle sont :

- ☐ a. Struvite
- ☐ b. Phosphate de calcium
- ☐ c. Cystinique
- ☐ d. Acide urique
- ☐ e. Whewellite

QUESTION 49

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les facteurs suivants, vous retenir comme facteurs de risque pour les bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE) :

- ☐ a. Une antibiothérapie récente par une céphalosporine de 2^{ème} génération
- ☐ b. Une antibiothérapie récente par la fosfomycine
- ☐ c. Une vie en institution
- ☐ d. Une hospitalisation dans les 3 derniers mois
- ☐ e. La présence d'une sonde à demeure

QUESTION 50

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

L'antidote de l'intoxication par les opiacés et morphinomimétiques est :

- ☐ a. Le bicarbonate de sodium
- ☐ b. L'atropine
- ☐ c. L'éthanol
- ☐ d. Le Flumazénil
- ☐ e. La naloxone



QUESTION 51

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

La(es) proposition(s) suivante(s) sont relatives à l'effet stabilisant de membrane :

- ☐ a. Il se manifeste par un élargissement du QRS à l'électrocardiogramme
- ☐ b. L'allongement de QT est la première anomalie électrique détectée
- ☐ c. Le bicarbonate de Sodium est le traitement de référence
- ☐ d. Il peut survenir au cours des intoxications par le lithium
- ☐ e. Il peut s'associer aux intoxications par les benzodiazépines

QUESTION 52

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le syndrome nicotinique observé lors des intoxications aux organophosphorés comporte :

- ☐ a. Un myosis serré en tête d'épingle
- ☐ b. Une stimulation sympathique
- ☐ c. Une hypersécrétion de toutes les glandes endocrines et exocrine
- ☐ d. Une tachycardie
- ☐ e. Des fasciculations musculaires

QUESTION 53

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les indications de l'oxygénothérapie hyperbare au cours de l'intoxication au monoxyde de carbone (CO) comportent :

- ☐ a. La survenue d'un état de mal convulsif suite à l'intoxication
- ☐ b. La femme enceinte
- ☐ c. La survenue d'une insuffisance rénale aigue
- ☐ d. Les antécédents d'hypertension artérielle
- ☐ e. Les enfants de bas âge



QUESTION 54

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

En faveur de l'origine centrale de l'hypothyroïdie :

- ☐ a. L'association à une hyperprolactinémie
- ☐ b. Les antécédents familiaux d'hypothyroïdie
- ☐ c. L'hypokaliémie sévère
- ☐ d. l'association à un goitre
- ☐ e. L'absence du myxœdème

QUESTION 55

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le bilan pré-thérapeutique d'une hypothyroïdie périphérique profonde doit comporter un (e):

- ☐ a. bilan hépatique
- ☐ b. électrocardiogramme
- ☐ c. électromyogramme
- ☐ d. bilan rénal
- ☐ e. NFS

QUESTION 56

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les signes cliniques d'une hypothyroïdie périphérique on retient :

- ☐ a. La dépilation axillo pubienne
- ☐ b. L'hypertension artérielle systolique
- ☐ c. La macroglossie
- ☐ d. L'asthénie
- ☐ e. L'amaigrissement



QUESTION 57

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une hypothyroïdie périphérique peut s'associer à:

- ☐ a. Une hyperuricémie
- ☐ b. Une hypercalcémie
- ☐ c. Une Anémie
- ☐ d. Une Hypocholestérolémie
- ☐ e. Une augmentation de TSH

QUESTION 58

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Au cours de l'hyperthyroïdie par surcharge iodée de type II (lésionnelle) :

- ☐ a. L'hyperthyroïdie est liée à l'effet toxique de l'iode sur les thyrocytes
- ☐ b. La scintigraphie est blanche
- ☐ c. La thyroïde est dystrophique et hypervascularisée à l'échographie
- ☐ d. Le taux de thyroglobuline est effondré
- ☐ e. Les anticorps antithyroperoxydases sont positifs

QUESTION 59

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

L'hyperthyroïdie au cours d'une thyroïdite subaiguë :

- ☐ a. Peut être d'origine auto-immune
- ☐ b. Succède à une longue phase d'hypothyroïdie
- ☐ c. Peut-être en rapport avec la prise exogène d'hormones thyroïdiennes
- ☐ d. Est sévère et prolongée
- ☐ e. Peut être d'origine virale



QUESTION 60

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, laquelle est compatible avec le diagnostic d'une hyperthyroïdie fruste :

- ☐ a. Le taux de TSH est bas et le taux de FT4 est élevé
- ☐ b. Le taux de TSH est élevé et le taux de FT4 est normal
- ☐ c. Le taux de TSH est normal et le taux de FT4 est élevé
- ☐ d. Le taux de TSH est bas et le taux de FT4 est normal
- ☐ e. Le taux de TSH est normal et le taux de FT4 est bas

QUESTION 61

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

La calcitonine chez l'homme :

- ☐ a. Stimule la formation osseuse ostéoblastique
- ☐ b. Constitue un traitement efficace de l'hypocalcémie
- ☐ c. Bloque la résorption osseuse ostéoclastique
- ☐ d. Provoque une hypercalcémie
- ☐ e. Provoque une hyperphosphatémie

QUESTION 62

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

La parathormone :

- ☐ a. Elle inhibe la 1-alpha hydroxylase rénale
- ☐ b. Provoque une hyperphosphorémie
- ☐ c. Elle inhibe la sécrétion de calcitriol
- ☐ d. Elle stimule l'ostéolyse
- ☐ e. Elle stimule la réabsorption tubulaire du calcium



QUESTION 63

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

La présence d'une hypophosphorémie associée à une hypercalcémie évoque en premier lieu :

- ☐ a. Une métastase osseuse
- ☐ b. Une intoxication à la vitamine D
- ☐ c. Un apport excessif en produits laitiers
- ☐ d. Un myélome multiple
- ☐ e. Une hyperparathyroïdie primaire

QUESTION 64

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est ou sont celle(s) vraie(s) ? :

- ☐ a. Le taux de bicarbonates est augmenté au cours de l'hyperparathyroïdie primaire
- ☐ b. La réabsorption rénale du calcium et du phosphore est élevée au cours de l'ostéolyse métastatique
- ☐ c. La calciurie est élevée au cours de l'ostéolyse métastatique
- ☐ d. La PTH est augmentée au cours de l'ostéolyse métastatique
- ☐ e. La calciurie peut-être élevée au cours de l'hyperparathyroïdie primaire

QUESTION 65

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, quelles sont les causes d'hypercalcémie :

- ☐ a. Hyperparathyroïdie primaire
- ☐ b. Ostéomalacie
- ☐ c. Syndrome de Cushing
- ☐ d. Sarcoïdose
- ☐ e. Hyperthyroïdie périphérique



QUESTION 66

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

L'autorégulation du débit sanguin rénal fait intervenir les facteurs suivants :

- ☐ a. Activité myogénique des fibres musculaires lisses
- ☐ b. Innervation sympathique
- ☐ c. Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire
- ☐ d. Facteur atrial natriurétique
- ☐ e. Aldostérone

QUESTION 67

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

La pression d'ultrafiltration (PUF) augmente en cas :

- ☐ a. De présence d'un obstacle sur les voies urinaires
- ☐ b. De vasoconstriction de l'artériole afférente et vasodilatation de l'artériole efférente
- ☐ c. De vasodilatation de l'artériole afférente et vasoconstriction de l'artériole efférente
- ☐ d. D'augmentation de la surface mésangiale
- ☐ e. D'augmentation du coefficient de filtration (Kf)

QUESTION 68

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

La régulation extrinsèque du débit de filtration glomérulaire fait intervenir :

- ☐ a. Le FAN
- ☐ b. La vasopressine
- ☐ c. Le Système rénine angiotensine systémique
- ☐ d. Le système nerveux sympathique
- ☐ e. Les propriétés vasomotrices de la paroi des artérioles

QUESTION 69

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

La vasoconstriction de l'Artériole efférente est favorisée directement par :

- ☐ a. Les kinines
- ☐ b. Les catécholamines
- ☐ c. La rénine
- ☐ d. Le Facteur atrial natriurétique
- ☐ e. L'Ag II locale

QUESTION 70

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le ou les situations suivantes peut ou peuvent diminuer la filtration glomérulaire :

- ☐ a. La respiration sous pression négative
- ☐ b. La grossesse
- ☐ c. L'exercice physique
- ☐ d. La contraception par une pilule œstro-progestative
- ☐ e. L'obstruction des voies urinaires

QUESTION 71

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les cellules de la macula densa :

- ☐ a. Libèrent l'angiotensine II
- ☐ b. Sécrètent un médiateur paracrine qui entraîne une vasoconstriction de l'artériole afférente
- ☐ c. Libèrent la rénine
- ☐ d. Sont sensibles à la quantité de NaCl dans le fluide tubulaire
- ☐ e. Sont sensibles à l'osmolarité plasmatique



QUESTION 72

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Choisir la ou les réponse(s) justes :

- ☐ a. Au cours d'un EDC hémorragique, la dette en oxygène est compensée initialement par une augmentation de l'extraction de l'oxygène au niveau cellulaire
- ☐ b. Les lactates élevés lors de la prise en charge initiale d'un EDC hémorragique peuvent être corrigés par l'augmentation de l'extraction de l'oxygène par les cellules de l'organisme même sans intervention humaine pour rétablir une perfusion tissulaire adéquate
- ☐ c. La non restauration d'une perfusion tissulaire correcte au cours de la réanimation d'un EDC hémorragique risque d'entraîner un EDC réfractaire
- ☐ d. Au cours d'un EDC hémorragique, la vascularisation splanchnique est privilégiée vu que la médullaire rénale a une extraction élevée d'oxygène à l'état de base
- ☐ e. L'acidose métabolique observée au cours de l'EDC hémorragique explique la polypnée observée.

QUESTION 73

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Un jeune homme de 23 ans est admis aux urgences pour prise en charge d'un polytraumatisme suite à un accident de la voie publique.

Le bilan lésionnel initial montre un pneumothorax droit qui a été drainé et un bassin instable.

La TA est à 120/90 mmHg, la FC à 120 battements par minute. La FR est à 28 cycles/min.

Il est un peu anxieux, les extrémités sont froides.

Il a déjà reçu un remplissage par un litre de cristalloïdes et a eu des morphiniques en sous cutané pour gérer la douleur qui a été contrôlée.

Il a par ailleurs été chauffé (couverture chauffante et cristalloïdes perfusés tièdes).

1/ Choisir la ou les réponse(s) justes :

- ☐ a. Ce patient présente un EDC obstructif.
- ☐ b. La mise en place d'une sonde vésicale est nécessaire pour surveiller la diurèse et mieux optimiser l'état hémodynamique du patient
- ☐ c. L'état hémodynamique de ce patient est plutôt rassurant
- ☐ d. Ce patient présente un EDC hémorragique stade I.
- ☐ e. Ce patient présente un EDC hémorragique stade II.

QUESTION 74

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les signes suivants d'hypoglycémie, quels sont ceux qui sont en rapport avec une neuroglucopénie ?

- ☐ a. Les sueurs froides
- ☐ b. L'irritabilité
- ☐ c. La fringale
- ☐ d. Les troubles mnésiques
- ☐ e. L'agressivité

QUESTION 75

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelle est la définition de l'hypoglycémie sévère chez un patient diabétique ?

- ☐ a. Une glycémie < 0,7 g/L avec des signes adrénergiques
- ☐ b. Une glycémie < 0,6 g/L
- ☐ c. Une hypoglycémie qui nécessite l'intervention d'une tierce personne pour être reconnue et/ou traitée
- ☐ d. Une hypoglycémie nocturne
- ☐ e. Une hypoglycémie suivie par une hyperglycémie réactionnelle

QUESTION 76

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Un diabète de type 1 est suspecté chez un patient âgé de 32 ans. Quel(s) autoanticorps faut-il rechercher pour confirmer ce diagnostic ?

- ☐ a. Anticorps anti-peptide C
- ☐ b. Anticorps anti-glucagon
- ☐ c. Anticorps anti-ZnT8
- ☐ d. Anticorps anti-glucokinase
- ☐ e. Anticorps anti-glutamate acide décarboxylase (anti-GAD)



QUESTION 77

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Au cours de la déshydratation hyponatrémique :

- ☐ a. Le secteur intracellulaire n'est pas touché
- ☐ b. Le mouvement de l'eau se fait du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire
- ☐ c. Le choc hypovolémique est rare
- ☐ d. Les pertes hydrosodées sont hypotoniques au plasma
- ☐ e. La déshydratation extracellulaire est prédominante

QUESTION 78

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Au cours de la déshydratation isonatrémique :

- ☐ a. Les pertes hydrosodées sont isotoniques au plasma
- ☐ b. La déshydratation intracellulaire est prédominante
- ☐ c. La correction du déficit hydrosodé doit être sur 48h
- ☐ d. Pas de mouvement d'eau entre le secteur intracellulaire et le secteur extracellulaire
- ☐ e. Le choc hypovolémique est fréquent

QUESTION 79

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une mydriase bilatérale et symétrique est compatible avec :

- ☐ a. Une intoxication à l'atropine
- ☐ b. Un engagement temporal
- ☐ c. Une lésion bulbaire
- ☐ d. Une intoxication morphinique
- ☐ e. Une lésion protubérantielle

QUESTION 80

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Concernant la réanimation volémique d'un brûlé grave :

- ☐ a. La diurèse des 24 heures est un paramètre fiable de surveillance
- ☐ b. Il est recommandé de perfuser 20 ml.kg⁻¹ de colloïdes au cours de la première heure
- ☐ c. Tient compte uniquement de l'étendue de brûlures
- ☐ d. Elle est calculée selon la formule de Parkland qui est la plus utilisée
- ☐ e. Une majoration des besoins de 30 à 50 % est prévisible lorsque s'associent à la brûlure un traumatisme ou des lésions d'inhalation de fumée.

QUESTION 81

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le choc initial du brûlé grave est :

- ☐ a. Associée à une baisse de la saturation veineuse centrale en oxygène(SvcO₂ <65%)
- ☐ b. Un choc cardiogénique
- ☐ c. Associée à une augmentation des résistances vasculaires systémiques
- ☐ d. Caractérisée par une augmentation des pressions de remplissage du cœur droit
- ☐ e. Un choc hypovolémique par plasmorragie interne et plasmorragie extériorisée

QUESTION 82

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les conséquences métaboliques dans les suites de brûlures graves associent :

- ☐ a. Une sécrétion intense et prolongée de catécholamines endogènes
- ☐ b. une hyperglycémie
- ☐ c. une production hépatique accrue des protéines de l'inflammation
- ☐ d. une sensibilité tissulaire accrue à l'insuline
- ☐ e. Un catabolisme musculaire et une protéolyse



QUESTION 83

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quelles sont les propositions exactes :

- ☐ a. Une brûlure de 2 degré superficiel guérit par desquamation spontanée en 2 à 3 jours
- ☐ b. Les brûlures profondes cicatrisent en 3 étapes: détersion, bourgeonnement, épithélialisation
- ☐ c. L'infection est la complication majeure de brûlures graves
- ☐ d. Une brûlure de 3ème degré guérit par cicatrisation spontanée en 3 semaines
- ☐ e. Les brûlures superficielles ne nécessitent pas un pansement

QUESTION 84

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Quels sont parmi les suivants, les facteurs de gravité des brûlures :

- ☐ a. L'exposition aux fumées d'incendie
- ☐ b. L'âge avancé
- ☐ c. Les brûlures de l'abdomen
- ☐ d. Un traumatisme crânien associé
- ☐ e. L'atteinte de la face antérieure de cou

QUESTION 85

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

La prostatectomie radicale :

- ☐ a. Est le traitement du cancer de la prostate métastatique
- ☐ b. Peut se faire par voie transvésicale
- ☐ c. Nécessite un drainage vésical de 48 heures
- ☐ d. Est une intervention à risque hémorragique
- ☐ e. Les vésicules séminales doivent être enlevées en même temps en monobloc



QUESTION 86

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le cancer de la prostate :

- ☐ a. Est oestrogéno-dépendant
- ☐ b. Est lymphophile et ostéophile
- ☐ c. Se développe à partir de la zone centrale de la prostate
- ☐ d. Est le 3ème cancer urogénital en Tunisie
- ☐ e. Est un carcinome à cellules claires dans la majorité des cas

QUESTION 87

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

La prise en charge de la bronchiolite aigue grave chez le nourrisson comprend :

- ☐ a. La corticothérapie inhalée
- ☐ b. L'oxygénothérapie
- ☐ c. L'antibiothérapie
- ☐ d. Le fractionnement des repas
- ☐ e. Les béta2mimétiques à courte durée d'action par voie inhalée

QUESTION 88

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les complications aigues de la bronchiolite aigue du nourrisson sont :

- ☐ a. La bronchiolite oblitérante
- ☐ b. La déshydratation aigue
- ☐ c. L'insuffisance respiratoire aigue
- ☐ d. Le pneumothorax
- ☐ e. L'asthme viro-induit



QUESTION 89

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les signes cliniques évocateurs d'une bronchiolite aigue chez le nourrisson sont :

- ☐ a. La durée de la fièvre supérieure à une semaine
- ☐ b. La toux
- ☐ c. Le freinage expiratoire
- ☐ d. La diarrhée
- ☐ e. La dyspnée

QUESTION 90

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Dans l'arthrite septique chez le nouveau-né

- ☐ a. La fièvre peut être absente du tableau clinique
- ☐ b. L'atteinte peut être multifocale
- ☐ c. Le traitement est médico-chirurgical
- ☐ d. Le germe est multi sensible
- ☐ e. Le résultat de l'antibiogramme est indispensable avant le traitement

QUESTION 91

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Devant une suspicion d'arthrite septique chez l'enfant :

- ☐ a. L'absence de fièvre élimine le diagnostic
- ☐ b. Il existe un syndrome inflammatoire biologique
- ☐ c. Une radiographie normale n'élimine pas le diagnostic
- ☐ d. La ponction articulaire permet la confirmation diagnostique
- ☐ e. Une échographie est demandée à la recherche d'un épanchement



QUESTION 92

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Le traitement d'une arthrite septique comprend :

- ☐ a. une arthrotomie avec lavage articulaire et drainage
- ☐ b. une antibiothérapie par voie orale dès la réalisation des hémocultures
- ☐ c. une antibiothérapie à large spectre adaptée ensuite à l'antibiogramme
- ☐ d. une immobilisation du membre
- ☐ e. une bithérapie à forte dose

QUESTION 93

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Les signes radiologiques en faveur d'une arthrite septique :

- ☐ a. Présence d'une Lacune épiphysaire
- ☐ b. Présence d'une luxation articulaire
- ☐ c. Présence d'un triangle de Codmann
- ☐ d. Présence d'un Pincement de l'interligne articulaire
- ☐ e. Refoulement des parties molles

QUESTION 94

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Parmi les propositions suivantes choisissez les réponses justes :

- ☐ a. Le traitement de l'arthrite septique est médico-chirurgical
- ☐ b. L'antibiothérapie doit être probabiliste puis adaptée à l'antibiogramme
- ☐ c. La confirmation diagnostique de l'arthrite septique est radio-clinique
- ☐ d. Le staphylocoque est le germe le plus incriminé dans les arthrites septiques
- ☐ e. L'antibiothérapie est de courte durée et par voie orale



QUESTION 95

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Devant une insuffisance surrénalienne aigue chez un nouveau né de sexe féminin, le bloc enzymatique en 21 hydroxylase est évoqué devant :

- ☐ a. L'ambigüité sexuelle
- ☐ b. Un taux de 11 désoxycorticostérone (DOC) élevé
- ☐ c. La mélanodermie
- ☐ d. Les antécédents de mort néonatale chez le frère
- ☐ e. Une ACTH basse

QUESTION 96

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Une insuffisance surrénalienne lente traitée par hydrocortisone peut être décompensée par :

- ☐ a. Une diarrhée
- ☐ b. Un régime hypercalorique
- ☐ c. Un régime riche en sel
- ☐ d. Une pyélonéphrite aigue
- ☐ e. La prescription de phénobarbital

QUESTION 97

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Au cours d'une HBP, le Toucher Rectal permet de trouver :

- ☐ a. Une prostate augmentée de volume
- ☐ b. Une prostate lisse et régulière
- ☐ c. Une prostate douloureuse siège d'une lésion ramollie
- ☐ d. Un nodule prostatique dur au niveau lobe
- ☐ e. Un effacement du sillon médian



QUESTION 98

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Quels sont les arguments en faveur de l'anémie inflammatoire ? :

- ☐ a. Absence de syndrome tumoral
- ☐ b. Contexte de polyarthrite rhumatoïde
- ☐ c. Signes de sidéropénie
- ☐ d. Malobservance au traitement
- ☐ e. Fièvre

QUESTION 99

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Quel est l'examen qui permettrait de confirmer le diagnostic ? :

- ☐ a. La CTF
- ☐ b. La transferrine
- ☐ c. La Ferritine
- ☐ d. Le Fer sérique
- ☐ e. Le dosage vitaminique

QUESTION 100

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

4/ Quelle serait votre conduite à tenir ? :

- ☐ a. Education de la patiente
- ☐ b. Supplémentation en fer oral
- ☐ c. Supplémentation en vitamine B12
- ☐ d. Traitement de la polyarthrite rhumatoïde
- ☐ e. Transfusion en CGR



QUESTION 101

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un nourrisson de 2 ans consulte pour une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, évoluant depuis 24h avec une fièvre non chiffrée.

A l'examen : Etat général moyen, température à 39°C, une douleur à la mobilisation de la hanche droite.

Au bilan biologique : GB 17000 /mm³ ; VS : 60 mm; CRP : 80 mg/l.

1/ Quel est le diagnostic à évoquer en premier lieu chez cet enfant :

- ☐ a. Arthrite réactionnelle
- ☐ b. Ostéomyélite du col fémoral
- ☐ c. Arthrite inflammatoire de la hanche droite
- ☐ d. Rhume de hanche
- ☐ e. Arthrite septique de la hanche droite

QUESTION 102

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Quels Examen radiologique demandez-vous de première intention afin d'étayer votre diagnostic ?

- ☐ a. IRM du bassin
- ☐ b. Echographie de la hanche
- ☐ c. TDM du bassin
- ☐ d. Scintigraphie osseuse
- ☐ e. Radiographie du bassin

QUESTION 103

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Un enfant âgé de 12 ans est amené aux urgences le soir par ses parents qui sont inquiets de le voir boiter douloureusement depuis le matin.

Il présente depuis l'après-midi une fièvre à 39° et il a mal au tiers distal de la cuisse droite avec une impotence fonctionnelle.

Le genou est douloureux, chaud avec un choc rotulien

1/ Quel diagnostic évoquez-vous ?

- ☐ a. Ostéomyélite du fémur distal droit
- ☐ b. Rhumatisme articulaire aigu
- ☐ c. Hygroma du genou
- ☐ d. Epiphysiolyse fémorale supérieure
- ☐ e. Arthrite septique du genou droit

QUESTION 104

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Un bilan sanguin a été pratiqué montrant un syndrome inflammatoire biologique. Quels sont les examens complémentaires à demander devant ces résultats ?

- ☐ a. Une scintigraphie osseuse
- ☐ b. Une échographie du genou
- ☐ c. Une radiographie du genou
- ☐ d. Une IRM du genou
- ☐ e. Une TDM

QUESTION 105

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Mme S âgée de 27 ans, aux antécédents de maladie cœliaque, est adressée pour suspicion d'une hyperthyroïdie.

Elle rapporte des palpitations et un amaigrissement de 15 Kg en un an. Elle se plaint également de douleurs abdominales et d'une constipation chronique.

L'examen de la thyroïde retrouve un goitre hétérogène avec un nodule lobaire droit de 2 cm.

Les explorations biologiques révèlent une hypocholestérolémie, une anémie microcytaire à 10 g/dl et une hypocalcémie à 1,9 mmol/l.

1/ Le diagnostic d'hyperthyroïdie chez cette patiente est suspecté devant:

- ☐ a. L'hypocalcémie
- ☐ b. Les douleurs abdominales avec constipation
- ☐ c. Les palpitations
- ☐ d. L'amaigrissement
- ☐ e. L'hypocholestérolémie

QUESTION 106

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Si le diagnostic d'hyperthyroïdie est confirmé, les arguments en faveur d'une maladie de Basedow sont :

- ☐ a. Les caractéristiques du goitre
- ☐ b. L'anémie microcytaire
- ☐ c. L'antécédent de maladie cœliaque
- ☐ d. L'âge et le sexe de la patiente
- ☐ e. L'évolution des signes cliniques évocateurs d'hyperthyroïdie depuis un an

QUESTION 107

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Le diagnostic de maladie de Basedow chez cette patiente est confirmé :

- ☐ a. Sans recours à des investigations supplémentaires
- ☐ b. Si l'échographie cervicale infirme la présence du nodule palpé
- ☐ c. Si la scintigraphie montre une hyperfixation diffuse et homogène du radioisotope
- ☐ d. Si les anticorps antithyroperoxydases sont positifs
- ☐ e. Si les anticorps antirécepteurs de la TSH sont positifs

QUESTION 108

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Un homme de 47 ans, diabétique de type 2 et tabagique, consulte aux urgences deux heures après ingestion d'une quantité non précisée d'un produit agricole liquide.

A l'examen initial : le patient est obnubilé, il présente des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées et une bradycardie avec un myosis serré en tête d'épingle.

L'examen note aussi une hypersalivation avec encombrement bronchique.

La SpO2 est de 88% à l'air ambiant.

1/ Le toxidrome présenté par le patient est :

- ☐ a. Anti-cholinergique
- ☐ b. Imipraminique
- ☐ c. Sédatif
- ☐ d. Sérotoninergique
- ☐ e. Cholinergique

QUESTION 109

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ L'examen complémentaire le plus utile pour confirmer le diagnostic est :

- ☐ a. Un dosage de la lipasémie
- ☐ b. Un ionogramme sanguin
- ☐ c. Un électrocardiogramme
- ☐ d. Un dosage de l'activité anticholinestérasique plasmatique
- ☐ e. Un dosage des antidépresseurs dans le sang et les urines

QUESTION 110

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Le traitement spécifique repose sur le ou les molécules suivantes :

- ☐ a. Atropine
- ☐ b. Le flumazénil
- ☐ c. La N-Acétylcystéine (NAC)
- ☐ d. Le charbon activé
- ☐ e. Le méthyl sulfate de pralidoxime

QUESTION 111

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

4/ La surveillance du traitement repose sur le ou le(s) mesure(s) suivante(s) :

- ☐ a. La surveillance de l'équilibre hydroélectrolytique
- ☐ b. Le dosage de l'activité cholinestérasique
- ☐ c. La surveillance de l'ECG
- ☐ d. L'état des pupilles
- ☐ e. La TDM cérébrale



QUESTION 112

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

Patient BC âgé de 19 ans a été ramené aux urgences par sa famille suite à une chute de sa bicyclette en marche avec réception crânio-faciale.

L'examen aux urgences trouve :

Une fréquence respiratoire à 16 cycles/minute, une saturation pulsée en oxygène à 98 % à l'air ambiant avec une ampliation thoracique normale.

A l'auscultation pulmonaire les murmures vésiculaires sont bien perçus et symétriques.

La pression artérielle est à 120/65 mm Hg, une fréquence cardiaque à 80 battements/mn

L'examen neurologique :

- Ouverture des yeux à l'appel
- Réponse verbale confuse
- Réponse motrice adaptée à la douleur

Pupilles intermédiaires et réactives

Au bilan lésionnel :

- Plaie frontale simple non déchiquetée de 3cm
- Ecchymose rétro-auriculaire gauche
- Hématome péri-orbitaire en lunettes.

1/ Le score de Glasgow est:

- ☐ a. 14
- ☐ b. 11
- ☐ c. 13
- ☐ d. 12
- ☐ e. 15

QUESTION 113

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ La sévérité du traumatisme crânien :

- ☐ a. Traumatisme crânien mineur
- ☐ b. Traumatisme crânien minime
- ☐ c. Traumatisme crânien grave
- ☐ d. Traumatisme crânien léger
- ☐ e. Traumatisme crânien modéré

QUESTION 114

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ L'examen complémentaire à demander:

- ☐ a. Aucun examen complémentaire
- ☐ b. Scanner cérébral
- ☐ c. Électrocardiogramme
- ☐ d. Radiographie du crâne
- ☐ e. Radiographie du thorax

QUESTION 115

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

4/Le patient a été hospitalisé aux urgences, quelles sont les paramètres cliniques à surveiller :

- ☐ a. Etat de conscience (GCS)
- ☐ b. Ionogramme sanguin
- ☐ c. Les signes de localisation
- ☐ d. Etat des pupilles
- ☐ e. La Pression artérielle

QUESTION 116

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

L'enfant HH, âgé de 4ans est ramené par ses parents pour asthénie et manque de réactivité. A l'interrogatoire, il est issu d'un mariage consanguin, un épisode d'ictère néonatal et jamais transfusé. A l'examen, vous notez une dysmorphie faciale, un ictère, avec une fièvre chiffrée à 38°. L'examen abdominal trouve une SMG à 10cm. L'état hémodynamique est stable.

NFS : GB : 9800/mm³ (PNN :6500/mm³)Hb : 7g/dl, VGM : 65fl, Rétic : 100000/mm³Plq : 450000/mm³Bilirubine totale : 40mmol/mm³ (VN<15mmol/mm³)

LDH : 450U/L (VN<180U/L)

CRP :100mg/l

Frrotis sanguin : hématies polychromatophiles

1/ Devant ce tableau, quel est le diagnostic le plus probable ? :

- ☐ a. Drépanocytose homozygote
- ☐ b. Déficit en Pyruvate Kinase
- ☐ c. β Thalassémie majeure
- ☐ d. DMinkowski chauffard
- ☐ e. Déficit en G6PD

QUESTION 117

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Comment confirme-t-on le diagnostic ? :

- ☐ a. Test de Coombs direct
- ☐ b. Test d'Emmel
- ☐ c. Dosage G6PD
- ☐ d. Test de résistance des globules rouges aux solutions hypotoniques
- ☐ e. Electrophorèse de l'Hb

QUESTION 118

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Quels sont les examens complémentaires à réaliser pour prise en charge en urgence ? :

- ☐ a. Le groupe sanguin avec phénotypage
- ☐ b. Les sérologies virales
- ☐ c. RAI
- ☐ d. Bilan infectieux
- ☐ e. Electrophorèse d'Hb pour les parents

QUESTION 119

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

4/ Quelle serait votre conduite à tenir ? :

- ☐ a. Transfusion
- ☐ b. Supplémentation en folates
- ☐ c. Antibiothérapie
- ☐ d. Supplémentation en fer
- ☐ e. Echange transfusionnel

QUESTION 120

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Cas clinique :

A. M, âgé de 19 ans, consulte pour un syndrome polyuropolydipsique.

A l'interrogatoire :

Antécédents familiaux de diabète chez la grand-mère paternelle, l'oncle paternel et le frère.

Opéré à l'âge de 6 ans pour un syndrome de la jonction pyélo-urétérale

Aucune prise médicamenteuse

A l'examen physique : Poids = 56 kg, indice de masse corporelle = 20 kg/m², tension artérielle = 12/7 cmHg.

Le reste de l'examen est sans particularités.

La glycémie capillaire = 2,3 g/L ; examen des urines par les bandelettes : Glycosurie = + ; cétonurie = 0

A la biologie : Glycémie veineuse à jeun = 2,1 g/L ; cholestérol total = 1,6 g/l ; triglycérides = 1,2 g/l ;

HDLc = 0,42 g/L ; créatinine = 60 µmol/L.

1/ Le diagnostic de diabète est retenu chez ce patient devant :

- ☐ a. La glycémie veineuse à jeun à 2,1 g/L
- ☐ b. La glycémie capillaire à 2,3 g/L
- ☐ c. Le syndrome polyuropolydipsique
- ☐ d. Les antécédents familiaux de diabète
- ☐ e. La glycosurie positive

QUESTION 121

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

2/ Quel est le type de diabète le plus probable chez ce patient ?

- ☐ a. Le diabète de type MODY
- ☐ b. Le diabète mitochondrial
- ☐ c. Le diabète de type 2
- ☐ d. Le diabète de type 1 lent
- ☐ e. Le diabète lipoatrophique

QUESTION 122

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

3/ Quelles mesures hygiénodététiques allez-vous prescrire chez ce patient ?

- ☐ a. Un apport quotidien en glucides de 200 à 250 g/j
- ☐ b. Une diminution de l'apport en fibres alimentaires
- ☐ c. Un régime hypocalorique
- ☐ d. Une activité physique régulière
- ☐ e. Une diminution de la consommation des aliments à index glycémique élevé

QUESTION 123

Pas encore répondu

Noté sur 1,00

Un homme âgé de 65 ans est admis aux urgences pour prise en charge d'un surdosage en AVK (coumarine: sintrom) avec un INR à 8 et un HSD (hématome sous dural) de 06 mm non encore compressif.

Comme antécédents, le patient est hypertendu depuis 20 ans, sous anticoagulants oraux pour fibrillation auriculaire sans notion d'AVC.

L'écho coeur est normale en dehors une hypertrophie ventriculaire gauche modérée et une taille de l'oreillette gauche limite.

1/ Quelle sera votre conduite à tenir pour ce patient :

- ☐ a. Le contrôle du bilan d'hémostase n'est pas nécessaire
- ☐ b. On peut donner du PFC à la dose de 20cc/kg
- ☐ c. Donner du PPSB (facteurs de coagulation) à la dose de 25 UI/kg et contrôler le bilan d'hémostase une heure après la fin de perfusion
- ☐ d. L'administration de la vitamine K n'est pas nécessaire
- ☐ e. L'antagonisation des anticoagulants est contre indiqué chez ce patient à risque d'AVC

Université de Tunis El Manar



